

氟喹诺酮类药物相互作用及不良反应

支向红¹ 闻嘉²

(1.河南省正阳县人民医院 河南正阳 463600; 2.广州医学院 广东广州 510182)

【摘要】第三代喹诺酮类药物氟喹诺酮类自从1979年合成以来,发展十分迅速。其共同特点是在化学结构7位上连以哌嗪环,6位处又引入了氟原子,从而大大提高了抗菌活性,增宽了抗菌谱。第三代喹诺酮类药物的结构中均有氟原子,故又称为氟喹诺酮类药物。目前应用于临床的有氟诺沙星、氧氟沙星、氟罗沙星、培氟沙星、环丙沙星等,本文主要介绍氟喹诺酮类药物的相互作用及不良反应。

【关键词】氟喹诺酮类药物 相互作用 不良反应

【中图分类号】R969.2

【文献标识码】A

【文章编号】1674-0742(2010)01(a)-0111-01

1 氟喹诺酮类药物的相互作用

1.1 利福平(RNA合成抑制药)、氯霉素(蛋白质合成抑制药)

可使本类药物的作用降低,使萘啶酸和氟哌酸的作用完全消失,使氟嗟酸和环丙氟哌酸的作用部分抵消。

1.2 茶碱类药物

通过研究证实,氟喹诺酮类药物抑制肝微粒体细胞色素P450同功酶,抑制茶碱的N位脱甲基化过程。从而使茶碱的清除率下降,茶碱血药浓度升高而中毒,老年人尤易发生。

1.3 多加金属阳离子

含铝镁的抗酸剂与环丙氟哌酸同时服用,可使后者血药活性几乎全部消失,碳酸钡可中等程度降低环丙氟哌酸和氟嗟酸的吸收,硫酸铝降低后者吸收作用则很强。其机理是上述含金属阳离子能与氟喹诺酮类的4-酮氧基-3-羟基发生络合作用,从而减少氟喹诺酮类的吸收及生物利用度,致使后者抗菌治疗失败。因此,临床应避免氟喹诺酮类与含镁、钙氢氧化物的抗酸剂或硫酸铝、硫酸亚铁、含锌的多种维生素合成,如不能避免时,在应用上述金属阳离子药物之前2h给予氟喹诺酮类药物,可使这一相互作用大为减轻。

1.4 H₂受体阻滞剂

甲氧咪胍能抑制肝细胞色素P450系统参与的I相代谢反应,因此凡在肝脏代谢氟喹诺酮类与之合用,均可使氟喹诺酮类肾外清除率下降24%。对健康人的研究表明,甲氧咪胍可使氟哌酸、氟嗟酸的肾清除减少5%~20%,清除半衰期处长30%^[1]。此外,氟喹诺酮类与华法令合用可使抗凝过度,凝血酶原时间延长而出血。与环孢素合用,可以引起急性肾功能不全,与卡氮芥合用可使后者对DNA损害加重,细胞毒性增大。氟哌酸可降低优降糖的口服生物利用度,故二者合用应监测血药浓度^[2]。

1.5 与布洛芬联合应用可致中枢兴奋、癫痫发作,与丙磺舒可延迟本品的排泄,导致肾清除率下降50%。但总清除率无改变。与氨基糖甙类、磺胺类、阿奇霉素及呋喃妥因等合用,可强化尿液,引起上述药物肾小管内析出,导致急性肾衰和阻塞性肾病。

2 氟喹诺酮类药物的不良反应

2.1 消化系统

主要表现为腹部不适或疼痛、腹泻、恶心、呕吐、食欲不振、黄疸等。平均发生率5%,最高达10%~13%,其顺序为:培氟沙星>环丙沙星>诺氟沙星>依诺沙星>氧氟沙星,其中以培氟沙星和环丙沙星的口服制剂最常见,环丙沙星口服随着剂量的增大而增

多。

2.2 神经系统

头昏、头疼、嗜睡、失眠等,偶可发生癫痫发作、神经异常、烦躁不安、意识模糊、幻觉、震颤。其发生顺序为:诺氟沙星>环丙沙星>依诺沙星>培氟沙星>氧氟沙星。

2.3 过敏反应

有皮疹、皮肤瘙痒、荨麻疹、心慌、痉挛,偶可发生渗出性多形红斑及血管神经性水肿,严重者可发生休克,其发生率为0.5%~2.2%^[3]。

2.4 肝肾损伤

少数患者可发生血氨基转移酶、血肌酐、尿素氮增高及周围血象白细胞降低,多属轻度,多呈一过性,其发生率为2%~4%。

随着氟喹诺酮类药物临床应用范围不断扩大,不良反应报告也日渐增多,肝肾功能不全和幼、老年患者,可使氟喹诺酮类药物药代动力学性质改变,延缓代谢,血药浓度增高,毒性增加,长期大剂量应用可致白内障、骨质疏松、心律失常、关节肿胀,由于对骨质有一定影响,孕妇、哺乳期妇女及婴幼儿应禁用。

临床应用氟喹诺酮类药物时应充分认识药物的适应症及不良反应的一些诱因,如患者年龄、体重、性别、病理及生理状况、给药剂量、静滴速度等,并注意不良反应的监测,以做到安全有效地使用药品,避免出现不良反应。

参考文献

- [1] 刘定勇,李良宏.氟喹诺酮类药物相互作用研究[J].国外医学·抗生素分册,1990,11(1):57~60.
- [2] 沈向忠,陆再再.氟喹诺酮类与其它药物的相互作用[J].国外医学·抗生素分册,1990,11(2):155.
- [3] 郑晓群,乔卫军.喹诺酮类药物临床应用不良反应及相互作用[J].中国抗生素杂志,1992,17(2):130.

【收稿日期】2009-11-27